

Informe de población G1/G2/G3

Andina Industrial S.A.C. · RUC 20512347781 · Sede Consolidado · Período 2026
Médico responsable: Dr. M. Salcedo Quiroz (CMP 48231) · Estado: Borrador · Versión 1

Población y cobertura

	Masculino	Femenino	Total
Trabajadores	0	2	2
Evalutados	0	2	2

Cobertura de vigilancia médica: 2 (100%)

Aptitud médico ocupacional

Apto: 1 (50%)
Apto con restricciones: 1 (50%)
No apto: 0 (0%)

Exámenes médicos ocupacionales

Ingreso	Periódico	Retiro	Total I-P-R
0	2	0	2

Enfermedades y problemas relacionados a la salud

Categoría	18-29 M	18-29 F	30-59 M	30-59 F	Total
Enfermedades del oído	0	0	0	1	1
Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	1	1
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	1	0	0	1

Enfermedades relacionadas al trabajo

Categoría	18-29 M	18-29 F	30-59 M	30-59 F	Total
Hipoacusia provocada por el ruido	0	0	0	1	1

Enfermedades profesionales y agentes de exposición

Grupo	Agente	Expuestos	Casos
Grupo 1 · Agentes químicos	Plomo	Pendiente de validación	0
Grupo 1 · Agentes químicos	Arsénico	Pendiente de validación	0
Grupo 1 · Agentes químicos	Cromo	Pendiente de validación	0
Grupo 1 · Agentes químicos	Mercurio	Pendiente de validación	0
Grupo 1 · Agentes químicos	Níquel	Pendiente de validación	0
Grupo 1 · Agentes químicos	Humos metálicos	0	0
Grupo 2 · Agentes físicos	Ruido	1	1
Grupo 2 · Agentes físicos	Vibraciones	0	0
Grupo 2 · Agentes físicos	Radiaciones	Pendiente de validación	0

Grupo 3 · Agentes biológicos	Agentes biológicos	0	0
Grupo 4 · Inhalación de sustancias y agentes	Sílice / polvo respirable	0	0
Grupo 4 · Inhalación de sustancias y agentes	Asbesto	Pendiente de validación	0
Grupo 4 · Inhalación de sustancias y agentes	Polvo de carbón	Pendiente de validación	0
Grupo 5 · Enfermedades de la piel	Agentes irritantes de la piel	1	0
Grupo 6 · Agentes carcinógenos	Agentes carcinógenos	Pendiente de validación	0

Población por grupo de riesgo

G1: **0** (0%)

G2: **1** (50%)

G3: **1** (50%)

Programas de vigilancia

Programa	Tipo	Población	Avance	Estado
Conservación auditiva	Ocupacional	412	78%	En curso
Protección respiratoria	Ocupacional	355	64%	En curso
Vigilancia ergonómica / musculoesquelética	Ocupacional	620	51%	En curso
Salud mental y fatiga	Ocupacional	1240	33%	Retrasado
Nutrición y riesgo cardiometabólico	Preventivo	780	88%	En curso
Población sensible (gestantes, discapacidad)	Sub-programa	46	95%	En curso
Capacitación anual SST	Capacitación	1240	72%	En curso

Conclusiones

1. Cobertura y cumplimiento de vigilancia: durante el período 2026 se registró una población laboral de 2 trabajadores (0 masculino / 2 femenino), de los cuales 2 contaron con evaluación médica ocupacional, equivalente al 100 % de cobertura.
2. Principales hallazgos de salud: la categoría con mayor número de casos fue "Enfermedades del oído" con 1 caso(s). La aptitud médico ocupacional se distribuyó en 1 apto(s), 1 apto(s) con restricciones y 0 no apto(s).
3. Enfermedades relacionadas al trabajo: se identificaron 1 caso(s) con clasificación previamente validada por el médico ocupacional. No se atribuye causalidad laboral a diagnósticos sin dicha validación.
4. Enfermedades profesionales: se registraron 1 caso(s) asociados a agentes de exposición con población expuesta identificada. Los agentes sin población validada figuran como información pendiente de validación.
5. Programas de vigilancia: se ejecutaron 7 programas de salud; 4 presentan un avance igual o mayor al 70 %. La población clasificada corresponde a 0 en G1, 1 en G2 y 1 en G3.

Recomendaciones

1. Continuar las evaluaciones médicas ocupacionales según el protocolo vigente por puesto de trabajo.
2. Mantener el seguimiento clínico de la población de riesgo (1 trabajadores G2 y 1 G3), con reevaluación según periodicidad establecida.

3. Fortalecer el programa de conservación auditiva y verificar la eficacia de la protección auditiva en los GES con exposición a ruido.
4. Reforzar la intervención cardiometabólica y nutricional en la población con dislipidemia, obesidad e hipertensión.
5. Desarrollar capacitación anual en salud ocupacional dirigida a la población evaluada y a los responsables de línea.
6. Realizar las reevaluaciones pendientes y cerrar los casos en seguimiento antes del cierre del período.

Documento generado por CUIDDA a partir de la información registrada en la plataforma. Las cifras provienen de consultas estructuradas a la base de datos; los textos narrativos requieren validación médica.